Pacient 3 r.č. 323456/3333 poj.
tel.

Ambulantní zpráva

Akutnost stavu: P3

Alergie:

neguje

CAVE:

syndrom suchého oka, protruze bulbů od dětství

FA:

Nolpaza 40mg tbl.1-0-0, Kinito 50mg tbl.1-1-1, Trombex 75mg tbl.0-1-0, Flixotide inh. 125mcg/dáv 1-1-1, Agen 10mg tbl.1-0-1, Enalapril 5mg tbl.1-0-1, Rosucard 40mg tbl.0-0-1, Lactulosa 667mg/ml dlp., Berodual 2ml inh. 3x/den, Acidum folicum tbl.1-0-0, Euthyrox 25mcg tbl.1-0-0, Alprox 0,25mg tbl.1-0-1, Tiapralan 100mg tbl.1-1-1, Mirtazapin 15mg tbl.0-0-0-2, Trittico AC 75mg tbl.2/3-2/3-0, Zaldiar tbl.1-1-1, Linola radioderm lokálně na RT pole 3-4x denně, vazelina lokálně na kanylu.

PA:

SD

RA:

onkologicky negativní

SA:

EA:

v kontaktu s inf. onemocněním nebyl

Abusus:

exfumator od 12/25, před iCMP 40cig/den, alkohol příležitostně

Nynější onemocnění:

- dg.C32.0 - spinoCa hrtanu, G2, p16-, R0 (blízky okraj)
- došetřová pro recid. infekty DC, zahlenění, chrapot trvající asi rok
- 11/25 ORL (FNO): na pr.hlasivce v přední 1/3 bělavý bradavičnatý povlak, až exofyt, hlasivka se zdá omezeně hybná, subglotický prostor volný
- 12/25 RTG plic: bez meta
- 8.12.2025 mikrolaryngoskopie + rozšířená chordektomie vpravo + rigidní ezofagoskopie (ORL FNO)
- peroper.: v oblasti ventrikulární řasy vpravo objemný exofytický a křehký tumor s navalitými okraji, překrývá a infiltruje pravou hlasivku, dosahuje přední komisury, nešíří se subgloticky, v úrovni zadní 1/2 pr.hlasivky je tuhý, lokalizován v obl. processus vocalis, kraniální část arytenoidu klidná, makr. radikálně resekován v rozsahu rozšířené chordektomie vpravo
- H: spinoCa G2, p16-, pT2 cN0M0
- ORL: provedena chirurgická terapie onkologicky dostačující, nicméně nutná pravidelná NBI dispenzarizace, a kontrolní direktoskopie s odstupem
- 12/25 UZ břicha: mírná hepatosteatóza., bez meta
- 12/25 UZ krku: reaktivní LU, nodularity ŠŽ
- 2026 kontrolní direktní laryngoskopie s prob.excizí + rigidní hypofaryngoskopie
- peroper.: exofytické trsy v.s. perzistujícího karcinomu pravého hemilaryngu, které postihují endolaryngeálně ventrikulární řasu supraglotis, také pravou hlasivku, kaudálně se šíří 2 cm pod úroveň hlasivek, dorzálně zasahuje do zadní komisury, volný okraj epiglotis klidný, valekuly volné.
- 23.1.2026 CT krku: TU pr.hlasivky šířící se převážně kraniálně supragloticky, méně též infragloticky, CC 33mm, patrná osteolýza štítné chrupavky vpravo ventrálně a arytenoidní chrupavky vpravo, bez signifikatní lymfadenopatie
- 01/26 RTG plic: bez meta
- 01/26 UZ břicha: bez meta
- 01/26 implantace PEG
- 01/26 chir.extrakce zubů
- 02/26 FGSK: vícečetné vředy Forrest III bulbu duodena v terénu bulbitidy, PEG v těle žaludku in situ.
- 25.2.2026 totální laryngektomie + BND bilat. II-V + lobektomie PL štítné žlázy (ORL FNO)
- H: spinoCa G2, p16-, Ki67 45%, L1, Pn0, blízky okraj (0,27 mm), prorůstá do štítné chrupavky, přes kterou nepřekračuje, LU v hlavním resekátu 1/0+, BND l.dx. 37/0+, BND l.sin. 20/0+, prelaryng.LU 1/0+, jazylka negat., PL ŠŽ: bez nádoru, koloidně-nodózní struma (tyreoidální folikulární nodulární nemoc), pT3N0
- protrahovaná krutoidní tracheitída

- 04-06/26 st.p. adjuvantní RT (lůžko hypopharyngo-laryngu/LU krku bilat., 70Gy/56Gy/35Fr)
- dnes 1.kontrola po RT

- 7.7.2026 kolaps v.s. vasovagální, hosp. na int. odd, dle CT mozku hematom v podkoží vpravo T-P, hyponatrémie s hypochlorémií (v.s. poléková po hydrochlorothiazidu)
- 07/26 RTG plic: bez meta
- 07/26 UZ břicha: bez meta
- 07/26 ORL (FNO): stoma i lumen trachey volné, bez krust

Dg.: C320

Diagnostický souhrn:

spinoCa hrtanu, pT3N0M0, G2, R0, p16-
- 25.2.2026 st.p.totální laryngektomii + lobektomii ŠŽ l.dx.+ BND bilat. II-V
- 01/26 st.p.implantaci PEG
- 04-06/26 st.p. adjuvantní RT (lůžko hypopharyngo-laryngu/LU krku bilat., 70Gy/56Gy/35Fr)

Další diagnózy:

spinoCa hrtanu, pT3N0M0, G2, R0, p16-
- 25.2.2026 st.p.totální laryngektomii + lobektomii ŠŽ l.dx.+ BND bilat. II-V
- 01/26 st.p.implantaci PEG
- 04-06/26 st.p. adjuvantní RT (lůžko hypopharyngo-laryngu/LU krku bilat., 70Gy/56Gy/35Fr)st.p. lakunární iCMP v povodí ACM vlevo 06/24 (konzervativní postup), RBBB chron., hypertenze, EF 70%, diastolická dysfunkce I.st., sklerosa Ao chlopně s lehkou reg. (dle ECHO 01/26), exfumator, anemie posthemoragická 02/26, duodenální vředy Forrest III 02/26, cholestatická hepatopatie (susp. DILI), protruze bulbů od dětství, syndrom suchého oka, st.p.APPE v dětství
st. p. zavedení perkutánní gastrostomie

Průběh kontroly:

Subj.: od RT bolesti v krku odezněly, trvá pocit překážky v krku, p.o. zvládá kašovitou stravu, jinak výživa 1000ml/PEG, krusty v průdušnici se tvoří méně, chodí čistit na ORL, chron. bolesti Lp, bez dyspepsii, bez teplot, bez kašel, chuť k jídlu má, zhubnul 2kg/3,5měs., stolice i močení v normě. KI 80%
Obj.: afebrilní, klidově eupnoický, spolupracující, orientován, mobilní, přiměřené hydratace a výživy, enorálně klidné, na krku TRCHST, bez kanyly, okolí klidné, jizvy na krku klidné, LU krku bilat.nehmatné, dýchání alveol., bez VDF, AS prav., břicho aperiton., bez palp.bolestivosti, bez hmatné rezistence, hepar a lien nehmatné, v epigastriu PEG, okolí klidné, DKK bez edémů, LU na periferii nehmatné.

Hmotnost [kg]:	71	**Výška [cm]:**	167	**BMI:**	25.46	**Plocha těla[m2]:**	1.8

VAS: 1 **PS:** 1

Doporučení:

- 2026, 8:15 - CT krku, plic, na CT 1, diagnostický komplement, FNO, nalačno, žádanka odeslána + vydána, souhlas vydán, vzít s sebou
- max. 14 dnů před CT prosím o odběr kreatininu v režii praktického lékaře nebo u nás, výsledek vzít s sebou na CT
- kontrola na ORL dle plánu
- kontrola zde -

Datum: **Podpis:**